小学生异常心理的类型及其识别与干预

郭 爱 鸽
(郑州师范学院 特殊教育系，郑州 450044)

摘　要:小学生常见的心理障碍有注意缺陷/多动障碍、品行障碍、焦虑障碍、恐惧症、儿童强迫症、创伤性应激障碍、抑郁症、精神发育迟滞、孤独症、儿童精神分裂症、沟通障碍和学习障碍等。小学教师需要敏锐地关注小学生心理世界的发展和变化，正确识别他们的异常心理表现，对他们的异常心理科学地进行干预，确保他们能够健康成长。

关键词:小学生异常心理;类型;识别;干预
中图分类号:G444　　**文献标志码**:A　　**文章编号**:1002－0845(2010)06－0127－07

小学阶段属于义务教育，其服务于全体适龄儿童。小学生的心理世界是丰富多变的，他们的心理健康问题日益引起社会的关注。小学教师既是知识的传播者和行为的示范者，也是孩子们心灵的美容师——心理保健者。许多一线教师熟悉并了解普通儿童的心理发展规律，但对于特殊儿童的心理特点却缺乏了解，在教育教学工作中，有时也会对小学生造成师源性的心理伤害，甚至会因为不能正确识别小学生的异常心理表现，错失干预时机，使其发展成为严重的心理障碍，造成无法挽回的后果。当前，小学教师亟须了解特殊儿童的心理特点，充分尊重儿童的个体差异性，从而做到因材施教。

一、小学生的异常心理

如果小学生无法有效地按社会规范或适宜的方式适应周围环境的要求，并表现出一系列心理活动的异常状态，那么，我们就说该小学生出现了心理障碍。心理障碍是指心理活动中出现的轻度创伤，是由不良刺激引起的心理异常现象[1]。这种在特定情境和特定时段出现的由不良刺激引起的心理异常现象，属于正常心理活动中暂时性的局部异常状态。许多小学生在遭遇父母离异、亲人死亡、人际关系冲突、中途转学、考试失败、重大灾害 (如地震、水灾、火灾、雪灾、海啸、泥石流、台风、车祸、空难、战争)等事件时，会表现出情绪焦虑、恐惧或者抑郁，或表现出沮丧、退缩、自暴自弃，或表现出愤怒甚至冲动报复等行为。这一系列适应不良的行为如果长期持续，得不到及时、恰当的疏导和调适，使其不能从负性情绪中解脱出来，那么就有可能导致精神疾病的产生。按照心理疾患的轻重程度，可以把心理障碍分为以下三种情况：1)轻微的心理失调；2)轻度的心理疾病 (有少部分小学生属于这种情况)；3)严重的心理疾病 (这类小学生是极少数的)。

二、小学生异常心理的类型及其识别与干预

小学生的常见的心理障碍包括注意缺陷/多动障碍、品行障碍、焦虑障碍、恐惧症、儿童强迫症、创伤性应激障碍、抑郁症、精神发育迟滞、孤独症、儿童精神分裂症、沟通障碍和学习障碍等。

1.注意缺陷/多动障碍

注意缺陷/多动障碍是小学生中常见的一种以注意力不集中、活动过度和行为冲动为主要特征的综合性心理障碍。其明显特征有活动过度、注意力难以集中、情绪不稳定、冲动任性、学习困难、品行不端、适应不良、神经系统存在某些功能性失调等。

注意力不集中、冲动和多动等症状往往会阻碍他们建立和保持与他人的友好关系，同伴问题以及来自父母、老师方面的频繁的消极反馈，常常会导致这些儿童形成低自尊[2]。当然，他们遇到的最大问题是在小学校的教室中。他们不能按照老师的要求安静地坐在座位上认真听讲，所以老师常常是最早发现他们问题的人。小学老师会发现他们表现出明显的注意分散症状，导致其学习效率低，容易分心，条理性差，难以在规定期限内完成任务，无法实现对社会的承诺或对同伴的许诺等；小学教师还会观察到他们在自我照顾、个人责任心、可信任度、独立性、社会关系及学业表现等方面正经历着困难。

收稿日期:2010－03－19
基金项目:全国教育科学“十一五”规划 2009年度教育部重点课题 (DHA090355)
作者简介:郭爱鸽 (1966－)，女，郑州人，副教授，从事特殊儿童心理与教育研究。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

注意缺陷/多动障碍影响了全世界几百万儿童的正常学习和生活，该障碍发生在男孩身上的几率比女孩大。目前，国内外很多学者对注意缺陷/多动障碍的病因和发病原理进行了研究。有证据表明，注意缺陷/多动障碍是神经生理性异常，患有注意缺陷/多动障碍的儿童，脑部某些区域的结构与正常儿童有所不同或者活动减少。生理和环境因素共同影响着注意缺陷/多动障碍的症状表现形式，它具有遗传性，也受社会环境的影响。研究发现，注意缺陷/多动障碍儿童常常来自于一些分裂的、不稳定的家庭，比如经常搬迁的家庭或父母离异的家庭。而且，注意缺陷/多动障碍儿童的父亲更倾向于不负责任，甚至表现出反社会的行为。面对教室里坐着的这种类型的小学生，作为老师首先需要正确识别多动行为和注意缺陷/多动障碍。对于那些具有多动行为的儿童，应从以下几个方面观察：是否还没有养成良好的学习习惯；是否学习环境的干扰过多；儿童的个性特点是否属于易冲动、脾气急的胆汁质类型。如果是，可针对具体情况制订辅导方案，对其进行行为调控方面的指导与训练。如果儿童患有注意缺陷/多动障碍，建议家长带孩子去专门的机构进行治疗。尽管目前国内外对注意缺陷/多动障碍尚没有彻底治愈的好办法，但有多种方法能够缓解注意缺陷/多动障碍儿童的症状。常用的方法包括药物治疗、家长管理培训、教育介入和心理咨询等。

2.品行障碍

品行障碍即儿童的品行问题和反社会行为，是指与儿童年龄不符的、不恰当的、违背家庭愿望和社会规范的、侵犯他人的人身权和财产权的行为和态度[3]。品行障碍的外化行为可以分为违法行为和攻击行为。违法行为指纵火、偷窃、酗酒、吸毒以及破坏公共财物的犯罪行为；攻击行为包括打架、破坏、不服从、挑衅、威胁他人以及在学校捣乱等[4]。

小学老师需要了解品行障碍的主要特征。对于品行障碍儿童一般应从以下几个方面进行观察和判断。1)对人和动物攻击方面的表现：经常欺负、威胁或恐吓他人；经常打架；使用能导致他人身体受到严重伤害的器械（如球棒、砖头、破瓶子、小刀、枪等）；曾对他人的身体进行残害；曾对动物的身体进行残害；曾面对受害者进行偷窃或抢劫（如背后袭击抢劫、攫取钱包、敲诈勒索、持凶器抢劫等）；强迫他人发生性行为。2)破坏财产方面：故意纵火，目的是造成严重危害；故意破坏他人财产（除了纵火）。3)欺骗或行窃方面：曾经破门而入他人的房子、建筑物或汽车；经常撒谎以骗取物品或好处而不履行义务（“哄骗”人）；曾经偷窃价值不菲的物品，而没有面对受害者（例如商店扒手）。4)严重违反规定方面：在13岁前就开始经常不顾父母的反对在外过夜；住在父母或监护人的家中时，曾经至少两次离家出走，在外过夜（或有一次离家很长时间未返回）；在13岁前就开始经常逃学。如果有证据表明，某小学生的行为在过去一年中出现以上特征中的3项（或更多），而在过去半年内至少出现其中的1项，就可以判断为品行障碍[4]。

10岁前就患有品行障碍的小学生中的大部分是男孩，他们表现出更多的攻击性症状，由此引发了一些与其年龄不成比例的违法活动，而且随着时间的推移他们的反社会行为仍然存在。研究表明，大概有40%的品行障碍儿童，长大后会形成反社会的人格障碍。小学老师还需要注意的一个群体是儿童品行问题的亚群体，这些小学生表现出一种冷漠无情的人际风格，其特点是缺乏负罪感、没有同情心、不表露感情，同时表现出与自恋和冲动有关的特质，这种特质使他们特别容易出现反社会行为和攻击性行为[4]。

品行障碍产生的原因主要有以下三个方面：1)家庭原因。父母婚姻发生冲突、被家庭成员所孤立、时常发生暴力事件的家庭、行为约束不正确、家长对孩子缺少及时有效的监督管理、出现危机的依恋关系、心中有强烈的不安全感的儿童、结构复杂且不稳定的家庭、父母有犯罪行为、父母心理有问题或障碍、父母有反社会的价值观等。2)社会原因。如崇尚暴力、低俗、功利、道德混乱的社会风气、不良的校风、社会黑势力的教唆引诱、媒体的负面宣传等。3)生理原因。有专家研究认为，低水平的皮层唤醒和低自主反应似乎对早期开始的品行障碍起着重要的作用。

对患有品行障碍的儿童进行干预的方法主要包括家长培训、“认知问题一解决技能”训练、多系统治疗、药物治疗等。研究发现，通过早期干预的强化计划可以预防儿童出现品行障碍。

3.焦虑障碍

所有的儿童在正常成长过程中都体验过恐惧、担忧、焦虑或羞怯，但过度的焦虑会影响他们的心理健康。焦虑障碍是指持续的精神紧张或发作性的惊恐状态，这些症状并非由实际威胁所引起，或者其紧张惊恐程度与现实事件不相称。

(1)广泛性焦虑障碍

患有广泛性焦虑障碍的儿童，几乎每天都会对很多事件和活动产生过度的、不可控制的焦虑，即使在没有任何诱因的情况下，他们也会担忧。他们的担忧可能是间断的，也可能是连续的。由于他们不能缓解焦虑，时间久了就会引起肌肉紧张、头疼或恶心、睡眠不安等。他们会把在网络、书籍、电影、电视、杂志、报纸、广播里耳闻目睹的任何一件令他们感到恐惧的事和自己联系起来，并为此担心、焦虑。比如要是看到一起有关公交车相撞的电视新闻报道，他们就担心自己可能遭遇车祸。所以，他们的脑海都是“如果……怎么办……”的问题。他们总是想象着可能会出现的最可怕的结果，他们不了解自己处理危机事件的潜能，也认识不到真正发生这些灾难的可能性是极其小的，反而认为灾难随时都会发生。在他们的心灵天空里，危险就像连绵

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不断的阴云笼罩在自己的头顶。广泛性焦虑障碍的重要临床特征是忧虑的不可控制性。它是小学生中最常见的焦虑障碍类型，患病率为 3%～6%，平均发病年龄为 10～14岁。

(2)分离性焦虑障碍

分离性焦虑障碍是指小学生在与父母分离或离家时表现出来的不适当的、过度的和影响行为能力的焦虑。患有分离性焦虑障碍的小学生常常对新的环境产生恐惧感，并伴有躯体不适症状。为了避免分离，他们时常会烦躁、哭泣、叫喊，甚至威胁父母如果离开就自杀 (虽然自杀很少发生)。他们出现的躯体不适包括疼痛、心率加快、眩晕、头痛、胃痛、恶心等。他们的父母 (尤其是母亲)，会感到非常痛苦。患有分离性焦虑障碍的儿童随着病情的发展会变得越来越退缩，出现感情淡漠和抑郁的现象[4]。

分离性焦虑障碍也是小学生中比较常见的焦虑障碍，患病率约有 10%，在男生和女生中都十分常见，相比较而言，女生的患病率高于男生。分离性焦虑障碍有一个从轻到重的发展过程。最初，可能是一些无害的理由，找些借口要求晚上与父母睡在一起；早晨上学时，从感到身体不适或偶尔不上学，逐步发展到每天因上学发脾气，最后完全拒绝上学；而且他们会越来越关注父母的行踪与日常的活动，总想和父母在一起；如果出现短时间的分离，就会表现出不安、担心、焦虑等状况。导致小学生出现分离性焦虑障碍的原因，主要可能是由于面对如上学、转学、搬家、父母不和、家人 (或宠物)生病与死亡等压力较大的情况适应不良等。教师和家长面对他们的表现，需要控制好自己的情绪，不要被孩子的坏情绪卷进去；采取大吼大叫、批评训斥、威胁恐吓、置之不理等方法都是不合适的，重要的是要认真、耐心地倾听他们的诉说，对于他们在焦虑时表现出来的担心和痛苦要表示理解和同情，并及时给予他们更多的关怀，舒缓他们的紧张情绪，消除他们内心的顾虑，以他们可以理解的生动形象的语言向他们解释产生焦虑的原因，教会他们在遇到困难时应如何去面对，鼓励他们独立、客观地迎接生命成长中出现的必然变化。考虑到他们是因为习惯于对主要依恋人的过度依赖，导致了他们的社会功能受到一定程度的影响，对这类小学生，老师可以组织他们开展生动、活泼的户外活动或游戏，吸引他们的注意力，用新的注意对象取代其对依恋者的过分关注。当然，还要充分考虑他们在活动中可能遇到的适应困难的问题，给予他们充足的时间去适应发展变化中的环境。一旦他们出现了我们期望的行为时，教师要及时给予鼓励，强化良好的行为。

4.恐惧症

(1)学校恐怖症

学校恐怖症是小学生对学校这一特定环境异常恐惧、强烈地拒绝上学的一种情绪障碍，是儿童恐怖症的一种特殊类型，是一种典型的心理适应不良综合征。除了情绪上的恐学、拒学状态之外，还与其他生理、心理上的缺陷有关。学校恐惧症的主要症状是害怕上学，有些儿童常以头痛、肚子疼为理由拒绝上学；有些儿童一进校门就恐慌不已，千方百计地逃避上学，严重者则逃学、旷课[3]。在小学阶段，该病症的发生年龄有两个高峰：5～7岁为第一高峰，可能与分离性焦虑有关；11～12岁为第二高峰，可能与升中学、功课增多、压力加大或转学重新适应新环境和人际交往困难等因素有关。

患有学校恐怖症的儿童在心理问题产生前均有诱因，如对学校特定的活动如考试感到恐惧、对特定的学科 (语文、数学、英语等)有恐惧感、对学校的某位领导或老师及同学感到恐惧等，一旦他们遭遇学习失败、在学校被批评、考试成绩不理想、受到同学的欺辱、冷落、孤立、报复、恐吓等，就表现出逃离学校的苗头。最初表现为上学很勉强，早晨拖延起床时间，向家长提要求，有的虽然答应去学校，但是到了学校或在路上就逃走了，有的宁可自己待在家中做作业、复习功课，也不愿去学校。有时他们会出现头疼、头晕、乏力、腹痛、腹泻、多汗、失眠、噩梦，甚至出现恶心、呕吐等症状，企图得到父母的同情，允许其暂不上学；一旦家长同意其可以不必上学，症状很快就消失或明显减轻。一天之中，早晨较为严重，下午少见。星期一较明显，双休日一般基本无症状。如果强迫儿童去学校的话，他们多会出现强烈的情绪反应，即使在学校也表现出退缩行为，如不敢直视老师，害怕被老师提问，做作业怕写错字、做错题，听讲时显得心慌意乱、情绪紧张；放学后则如释重负，并表示不肯再去学校，个别的儿童甚至出现逃学现象。有学校恐怖症的小学生，一般女孩多于男孩。

学校恐怖症形成的原因主要有：1)家长过分娇惯、溺爱孩子，使孩子形成较强的依赖性，不愿离开温暖的“安乐窝”、“保护伞”。凡事依附于父母，缺乏独立性，不愿面对生命中的成长，逃离成长过程中必要的挑战和努力。2)家庭中母亲为慢性焦虑症患者，对孩子安全过分关注，整天担心孩子离家上学会发生不幸事故。这种情绪渐渐地传染给了孩子，使孩子也感染上了这种负面情绪，内心没有安全感，害怕当自己上学时父母遭遇不幸，或担心自己在外面遭受意外伤害。3)在学习中遇到挫折时，就采取逃离学校的方式来应对。这类儿童往往学习成绩比较好，自尊心也比较强，当他们在学校遭受挫折或学习上出现问题时，常常会产生强烈的情绪反应和痛苦的内心体验，由于不能勇敢地去应对，就采取了逃避的方式。这时，如果父母处理问题的方式不恰当，就会强化他们的退缩行为。例如，认同他们的行为并采取附和、同情的态度，或对小学生的外出及上学过分担心、过于焦虑，均可使其学校恐怖症越来越严重。4)父母不考虑孩子的实际情况，由于存在“攀比”心理和虚荣心理，对孩子抱有过高的期望值，极力地让孩子在班级、年级、甚至学校争当第一，小学生由于达不

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

到父母的要求，因而试图逃避上学。5)父母婚姻破裂或家庭中夫妻关系、亲子关系、婆媳关系、妯娌关系等过分紧张，家庭冲突、家庭暴力频发，也会使孩子处于高度警觉状态，因对环境缺乏安全感，以致造成退缩、拒学。6)家庭遭遇突然变故，如亲人患病、去世、受伤、失踪、负债、被害、破产等，家庭成员情绪出现巨大的波动，也会使孩子因牵挂家人而无心上学。

(2)特异性恐怖症

患有特异性恐怖症的小学生对一些危险较小甚至没有危险的物体或情境表现出极度的、影响行为能力的恐惧，他们会想方设法地回避这些物体或情境[4]。尽管有证据证明没有恐惧的必要，周围的人也努力地去说服他们，但他们对恐惧的对象感觉危险的信念依然会持续存在，并不能意识到自己的恐惧是过度的、不合理的。大约2%～4%的小学生出现特异性恐怖症，它可以在任何一个年龄中出现，但10～13岁为发病的高峰期[4]。特异性恐怖症的诊断标准如下：在某一特定的物体面前或某一特定的情境下(如飞行、高空、动物、注射、看见血等)，或对这些物体或情境的想象中，出现明显的、持续的、过度的或不可控制的恐惧；面对恐惧对象，往往出现剧烈、持久的惊恐和回避反应，而且伴有相应的生理改变，如心跳加速、呼吸变快、出冷汗、面色苍白等植物神经系统症状[3]。行为反应有哭泣、发脾气、身体僵硬、缠着大人等。根据恐惧的对象不同，恐怖症可以分为以下几种类型：1)动物恐怖症，通常指猫、狗、鸟、老鼠、蛇和昆虫；2)自然环境恐怖症，包括污物、高度、黑暗、风、水和风暴等；3)情境恐怖症，包括桥、电梯、飞机、隧道、封闭的场所、公共运输工具等；4)血、注射和伤口恐怖症；5)其他恐怖症，包括疾病或死亡等[2]。

(3)社交性恐惧症

社交恐惧症是指明显并持续地对社交或一些自我表现的恐惧，因为这些场合可能引起他人对自己的关注或可能引起尴尬。患有社交恐惧症的儿童会想方设法回避这些场面，或通过很大努力装出一副无所畏惧的样子来接受挑战。他们内心特别渴望别人喜欢自己，但由于缺乏社交技能，又过于恐惧自己的行为可能会使自己丢脸，反而使他们陷入非常紧张、孤独、痛苦的情境之中。如果家长、老师或同学想强迫他们参加社交活动的话，他们可能会哭泣、发脾气、手脚僵硬，行为表现得更加退缩，最严重的后果是发展成为广泛性社交恐怖症。典型的表现是恐惧社交场合，害怕遇见陌生人或与陌生人说话，回避与家庭以外的人接触，不愿意上学，不愿意参加娱乐活动，拒绝社会化[4]。

社交恐惧症在10岁以下的儿童中比较少见，但发病率随着年龄的增长而增加。这主要是因为随着儿童自我意识的逐渐增强，他们会对来自他人的评价出现过度担忧。有些小学生在家里或其他场合可以大声与家人说话，但不会在某些社交场合说话，他们患的是社交恐惧症中的选择性缄默症。

(4)选择性缄默症

患有该症的儿童言语器官无器质性病变，智力正常，并且已经获得了语言功能。但在某些精神因素的影响下，在某些他们需要说话的社交场合却表现出顽固的沉默不语现象。选择性缄默症不属于沟通障碍，其实质是社交功能障碍。中国人的性格普遍比较内向，儿童在开始上幼儿园或小学时不说话，常常被认为是性格内向或害羞等，常被父母或老师忽略，造成患儿不能及时被发现和医治。他们多在3～5岁发病，女孩比较多见。患有选择性缄默症的儿童在某些特定场合因为焦虑或极度害羞，即使能够说话也不敢开口。研究发现，移民儿童、频繁的搬家或转换学校的儿童，得选择性缄默症的比例较高。引发选择性缄默症的原因主要有较大的社会压力、尖锐的社会矛盾、较高的社会流动性、频繁而复杂的家庭问题和家庭矛盾等。目前，随着现代社会的快速发展，患有选择性缄默症的儿童有增多的趋势。

选择性缄默症经过治疗大多数可以在数月至数年内康复。通常使用的治疗方法有：第一，心理治疗。以缓解儿童的内心冲突为主要目的，强调个体化治疗。具体方法有心理暗示、心理辅导、认知治疗等。第二，行为治疗。可以帮助儿童调节情绪，克服急躁和焦虑，纠正其处理问题的行为模式。常用的方法有正性强化法、负性强化法、脱敏法等。第三，家庭治疗，包括家庭教育和家庭游戏。应为患病儿童营造温馨的家庭环境，建立和睦的家庭关系，邀请朋友、同学和老师来家中做客、一起做游戏等。第四，学校和社会的参与。要给患儿创造一个安全、良好的校园环境和班级环境。在课堂上，最初应鼓励他(她)参与集体回答，回答人数逐渐减少，鼓励他(她)单独和老师交流，让其提前准备要回答的问题，然后小范围内由他(她)单独回答，老师或同学们用言语诱导、提示、配合他(她)回答问题，并逐渐将范围扩大。第五，药物治疗。一般不把药物治疗作为首选的治疗方法，但是如其他方法效果不好，可以把药物治疗引入到治疗方案中。第六，综合治疗。治疗方案包括心理治疗、行为治疗、家庭治疗、学校和社会的参与及可能的精神药物治疗等。

5.儿童强迫症

儿童强迫症是指没有客观必要性而又不断重复某些观念、意向或行为的症状。儿童主观上感到有一种不能克制、不可抗拒的观念、意向或行为，也意识到这是不合理的、不必要的或毫无意义的，但却无法控制和摆脱，因此感到十分苦恼[3]。患有强迫症的儿童每天体验着反复的、耗时的(每天超过1个小时)和干扰正常生活的强迫观念和强迫行为。强迫观念是指持续的、插入性的思维、意念、冲动或意象。由于强迫观念给其生活带来了大量的焦虑和痛苦，所以患强迫症的儿童总是想方设法用其他行为抵消强迫观念。这些行为被称为强迫行为，即重复的、有目的的、有意图的行

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为(如洗手)或心理活动(如不断默读某些词语),强迫行为或活动对应于强迫观念[4]。最常见的强迫行为是洗手、洗澡、重复、检查和布置,如一遍又一遍的数课本或其他图书上的人或物的数目、反复检查自己的书包是否整理好、反复数自己走了多少个台阶、反复检查自己的衣服或鞋袜是否摆放整齐、反复检查自己的抽屉、衣柜、房门是否锁好等。由于注意过度集中于强迫观念和强迫性仪式,使他们的正常的活动减少,他们的健康的社交、家庭关系以及学校的功能都受到了严重的影响[4]。

突发的精神创伤、高度的精神紧张、严重的躯体疾病以及环境的重大变迁等生活事件是诱发强迫症的重要因素;有些小学生由于先天素质不良,使其形成了谨慎、胆小、害羞、呆板、思考问题过多等性格特点,也容易诱发此病;学校的教育方法不当,如过于严格、苛求、作息制度过于刻板化等,也可能成为此病的诱发因素[3]。儿童强迫症的平均发病年龄为9～12岁,是一种严重的慢性疾病。

6.创伤后应激障碍

《心理障碍诊断与分类手册(第四版,修订版)》(DSM—Ⅳ—TR,美国精神病学协会,2000)对创伤的定义是:个人直接经历一个涉及死亡、或死亡威胁、或其他危及身体完整性的事件,或目击他人涉及死亡、或死亡威胁、或危及身体完整性的一个事件;或经历家庭成员或其他亲密关系者预期之外的或暴力的死亡、严重伤害,或死亡威胁和损害(标准A1)。此人对该事件的反应必须包括强烈的害怕、无助感和恐惧(儿童的表现可能是行为紊乱或激越)(标准A2)。创伤事件指战斗、性和躯体攻击、折磨、灾难、严重交通事故或威胁生命的疾病、事故、战争或灾难等[5]。

创伤后应激障碍的(症状持续1个月以上)核心特征为:1)反复重现创伤事件的体验。2)回避与创伤事件有关的刺激,对一般事件的反应显得麻木。3)极端的唤醒症状。患有创伤后应激障碍的儿童内心会出现强烈的恐惧和无助感,并可能通过不安和错乱的行为表现出这些情绪;还可能伴有持续多年的噩梦、恐惧和惊恐;出现发展中的退缩并表现出与年龄不适当的行为,如对陌生人的恐惧;还可能感到悲观、易受伤害,或麻木并出现学习问题[4]。面对创伤后应激障碍的儿童,小学老师给予他们及时、恰当的社会支持是十分必要的。对他们可以采取心理教育、情感调控训练、团体辅导、个体咨询等方式来进行干预。当然,必要时应建议家长带孩子去医院接受药物治疗。老师首先要对受创伤的儿童给予积极的关注和尊重,因为他们面对着潜在的令人崩溃的精神痛苦,他们在努力地面对自己的经历,有了来自老师的赞赏,他们会鼓起勇气,超越痛苦! 其次,老师要成为孩子心中希望火种的点燃者。我们不能为孩子承诺一切,但可以与他们讨论、交流并向他们灌输希望,因为希望是严重创伤、无望和绝望的解药[5]。再者,要给他们提供物质和心理都安全的环境。使他们身心完全放松,不必担心火灾、被攻击或是嘲笑、拒绝、批评、伤害、威吓等事件发生,这样他们才能卸下防御。

作为小学老师应该怎样帮助哀伤的孩子呢? 那就是去陪伴他们。陪伴是指用我们的心去聆听,用我们的眼睛来观看,并常常留意他们的语言、情绪及行为。当孩子们邀请我们进入他们的内心世界时,让我们以尊重、敏锐及耐性去与他们同行[6]。

7.抑郁症

如果在您的教室里坐着一位总是不开心、对任何事物都缺乏热情、情绪反复无常、甚至觉得生活没有意义的儿童,您需要考虑他(她)可能患上了抑郁症。

抑郁是一种广泛的不愉快的情绪,有时被称为“心理感冒”。每个儿童偶然都会感觉到哀愁、忧郁、不高兴或心情沮丧,但这些感觉很快会消失,他们又恢复了正常的活动。患抑郁症的儿童主要表现为否定性的自我评价;逃避社会交往,自我封闭;认为学习和生活没有乐趣,没有希望,没有意义;在身体症状方面经常无缘无故地感到疲倦,常感到身体不适,并经常出现睡眠障碍;此外,抑郁症儿童还会出现焦虑、恐惧等症状[3]。

抑郁症儿童表现出多种持续的症状,包括情绪、行为、态度和生理功能的缺损[4]。这种广泛的、影响行为能力的、持续的甚至是威胁生命的抑郁,需要父母和老师给予高度的重视。心理学的有关研究发现,小学生的抑郁症表现的症状有持续时间较长的情绪低落、易激惹、有破坏行为、好发脾气、好斗、自责、自卑、持续的忧郁和社会抑制等。他们可能会说“我很笨”或“没有人喜欢我”,并常会与家人产生隔阂。这些儿童可能会无法入睡或睡眠过多,他们的激惹性越来越高,失去快乐感或兴趣,学习成绩越来越差。与父母在一些有意见分歧的问题上经常发生争吵,对自己有较高的负性评价,自我意识较差。

儿童抑郁症多发生在8岁以上,女孩比男孩多见[3]。近年来的研究发现,儿童抑郁症的发病人数有增长的趋势,且患病年龄逐渐下降,儿童的抑郁症治愈后有复发的可能性。

引起儿童抑郁症的原因有很多,它是遗传、家庭、个人等多种因素交互作用的结果。父母患有抑郁症,他们的子女患有重度抑郁症(尤其是青春期前发病)的比例较高;抑郁儿童的家庭矛盾或冲突多,家庭成员间彼此不满,怨恨,互相指责,推卸责任;父母对子女的控制较多,但缺乏沟通,干涉多,缺少温暖和支持。孩子在家中常常感到情绪压抑,愉悦体验少。儿童生活中出现的重大变故,如父母离异、再婚或死亡、亲人的去世、家庭成员生病、严重的事故、搬家、转学等应激事件,都可能使儿童陷入深深的悲伤和痛苦之中。儿童的气质和性格特点如果呈现抑郁性,则常常会表现出内向、谨小慎微、沉

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

默寡言、情绪低落、消极悲观等特征，一旦他们遭遇负性生活事件时，产生抑郁的可能性极大。

目前，对抑郁症的治疗主要有社会心理治疗和药物治疗两种方法。“认知一行为”治疗法是儿童抑郁症的最佳治疗方法。作为小学老师，我们需要积极开展儿童抑郁症的预防工作。应邀请家长积极参与，认真配合，帮助有抑郁倾向的儿童建立良好的亲子关系、师生关系和同伴关系，指导他们掌握必要的社交技能，消除他们内心的压抑感，为他们疏解持续的痛苦情绪，通过科学及时的宣泄、转移，清除他们心灵里的情绪垃圾；为他们提供成功的成长体验，帮助他们塑造积极、乐观、勇于承受挫折的良好心态，让他们能够以开放的人生态度迎接“人生在世，不如意事常有八九”的现实生活。当然，对于有重度抑郁症的儿童，我们应建议家长寻求专业治疗，并对其加强监护。

8.精神发育迟滞

在我国，随着义务教育的普及，一些家长把自己精神发育迟滞的孩子也送到了普通小学就读，希望他们能在正常儿童群体中成长。他们的存在是对教师的教学和教育工作的挑战，我们应尊重这些孩子的受教育权，但需要为他们提供个别化的教育。精神发育迟滞就是我们常说的智力障碍。精神发育迟滞是指先天或围产期或在生长发育成熟以前（18岁以前），由于各种致病因素，如遗传、感染、中毒、头部外伤、内分泌异常或缺氧等，造成大脑发育受阻或不全，使其智能发育停留在一定的阶段，随着年龄的增长，其智能明显低于同龄的正常儿童[2]。精神发育迟滞是一种在童年期就明显表现出来的精神障碍。精神发育迟滞个体的智力和适应性功能均低于平均水平；其特征是明显的智力功能低下，并伴有下面两个或两个以上的适应性技能方面的缺陷：如沟通、自我照顾、家庭生活、社会技能、资源使用、自我指导、健康和安全、休闲和工作等。精神发育迟滞的患病率约为 1%，男性的患病率高于女性[2]。在我国常用韦氏智力测验测评智商，并用儿童社会适应行为量表测评其社会功能。

精神发育迟滞分为四个水平：1)轻度精神发育迟滞症。该类型患者所占的比例最大，约占 85%。这些儿童能够像其他儿童一样发展社会交往技能，常常在他们进入小学四年级或出现学习困难时，才被注意到可能患有精神发育迟滞。2)中度精神发育迟滞。中度精神发育迟滞儿童占所有精神发育迟滞案例的 10%。他们的学习能力最多能够达到小学二年级的水平，身体笨拙，运动协调能力不是太好。3)严重精神发育迟滞。严重精神发育迟滞儿童在五岁前就表现出了明显的动作发展不良，他们几乎不会与人交流。4)极重度精神发育迟滞。极重度精神发育迟滞儿童有严重的适应性行为障碍，身体有严重畸形，中枢神经系统发育不良，生长滞后，对疾病的抵抗能力很差，寿命一般短于正常人。

唐氏综合征是最普通的由染色体变异引发的精神发育迟滞，该病症一般是由第 21对染色体的变异引起的。该症存在着一些身体特征，如小头、小嘴大舌、杏目斜眉、扁平鼻梁、短而弯的五指和宽而方的带有猿（猴）掌纹的手等，可能还会有先天性的心脏畸形[2]。

虽然许多地区都有特殊学校，但是家长通常选择把轻度精神发育迟滞儿童送入普通小学学习。事实上，智力缺陷儿童常常被正常儿童所孤立，仅仅让他们呆在正常班级并不能提高他们的社会能力，教育的结果不太令人满意。这些孩子的成长体验并不愉快，他们很容易感到无助，常常会放弃对成功的期望，出现习得性无助。我们对这些孩子该做些什么呢？怎样为他们提供必要的支持和帮助呢？一些研究发现，对精神发育迟滞的儿童越早提供干预，其干预的效果越好。在安排干预方案时应充分考虑儿童个人的需要、能力等因素，同时调动家庭、学校、社区的支持力量。成功的干预常常包括基于行为治疗的训练和教育，目的是传授特殊的技能和减少不适当的行为[4]。社会心理治疗的主要方法有早期干预、行为治疗、“认知一行为”治疗等。王建平教授认为，面对精神发育迟滞的儿童，把正常的学习体制和特殊教育方法相结合是最好的方式。当然，有一个“知他懂他”的好老师也是非常重要的，这样的老师既相信自己的学生有学习能力，又能施行特殊教育。

9.孤独症

儿童精神病学家里欧·坎纳最早提出孤独症。他认为，“孤独症的核心特征是无法通过普通的方式与人和情境互动，极度的封闭孤独，在任何情况下都会轻视、忽视、排除任何外界事物进入的孩子”[2]。孤独症现在被认为是生物学基础上的终身的发展障碍，它在生命的头五年出现。这是一种广泛性的发展障碍，以严重的、广泛的社会相互影响和沟通技能的损害以及刻板的行为、兴趣和活动为特征。孤独症儿童的行为是怪异的、不寻常的，并经常以一些莫名其妙的方式表现出来。他们会花很多时间从事刻板的或重复的动作（如强迫性的常规和仪式、异常的关注和一致性坚持或刻板的身体运动），或专注于他们环境中微小的细节，而忽视大的方面[4]。

从外表和长相看，很难将孤独症儿童与正常儿童区分开。因为，他们的外表十分可爱、聪慧，有的胜过正常同龄儿童。生物学的研究发现，孤独症儿童的大脑发育存在着广泛的异常，这些异常导致了复杂的信息处理能力的一般性损害。男孩的患病率比女孩的患病率高 3～4倍。孤独症专家 U·Frith 认为，“孤独症患者承受着生物学缺陷带来的痛苦。虽然他们不能被治愈，但我们可以做很多事情来改善他们的生活”[4]。孤独症儿童的治疗主要是针对其特殊的社交、沟通、认知和行为的缺陷，使儿童的潜力最大限度被挖掘，帮助儿童及其家庭更有效地应付这种障碍。高度结构化的技能导向性

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

策略是对孤独症儿童最有效的治疗策略[4]。

亚斯伯格症这个名词对我们的许多小学老师来说是陌生的，它似乎比孤独症离我们更遥远。其实，一些患有亚斯伯格症的儿童正坐在我们的教室里，由于他们具有平均范围内的智商分数，也没有孤独症那样的语言迟缓和认知损伤，只是看起来动作笨拙，运动不协调，理解力差，人际关系不好，没有朋友。我们常常没有把他们当做特殊需要儿童来看待，只是把其当做差生而已。然而，研究发现，亚斯伯格症儿童的脑发育异常，他们的成长需要老师的特殊教育，而不仅仅是普通意义的严格要求。

10.儿童精神分裂症

儿童精神分裂症是一种精神性障碍，存在严重的症状，如怪异的妄想、幻觉、思维障碍、明显的行为紊乱、极不恰当或淡漠的情感和严重的功能减退或受损，在 12岁以下的儿童中极少见[4]。儿童精神分裂症最常见的症状是听幻觉，在 11岁前发病的儿童中，大约有 80%会出现听幻觉，大约 40% ～60%的儿童精神分裂症患者有视幻觉、妄想和思维障碍。有关的家庭研究发现，精神分裂症儿童的家庭通常存在应激、不幸和个人悲剧[4]。精神分裂症是一种慢性精神障碍，药物治疗可以帮助控制精神分裂症儿童的精神症状。除了药物治疗以外，还需要社会技能训练、家庭治疗、“认知一行为”治疗、认知恢复、个体化治疗和综合心理治疗等社会心理治疗，特殊教育对他们也是必需的。尽管他们在小学阶段出现的几率很小，但我们每遇到一个个案都需要及时为其提供专业的教育和全面的支持与保护，积极与家庭沟通、合作，要理解他们内心的痛苦和挣扎，认识到这是一种人脑疾病，这些儿童正在承受着巨大的个人苦难，极其需要成人的援助。

11.沟通障碍

沟通障碍是指发出语声方面的困难 (音韵学障碍)或言语不流利 (口吃)，不能使用口头语言沟通 (语言表达障碍)、或理解他人言语有困难 (“表达一接受”混合型语言障碍)[4]。语言表达障碍属于沟通障碍的一种，是指在语言的接受和表达之间的不一致。遗传和大脑成熟的缓慢与异常是产生沟通障碍的原因，早期耳部感染在一部分儿童的言语发展中起了干扰作用。

口吃是儿童常见的语言表达障碍之一，是指重复和拖长某些音节的发音以致妨碍交谈的语言现象。患儿的主要症状有：说话吃力，声音、音节或单词重复或延长，同时伴有跺脚、摇头、拍腿、上身摇晃或嘴唇颤动等动作[3]。引起儿童口吃的因素有以下几个方面：1)遗传。 2)环境。 3)精神，如受到突然的惊吓、适应不良、家庭冲突等。 4)模仿。口吃多在低龄儿童中出现，一般在 2～7岁之间发病，发病的高峰年龄是 5岁，男性是女性的 3倍。通常不需要对沟通障碍儿童进行治疗，许多症状在进入小学后不久就会被自动纠正，并恢复正常。

作为老师，我们要帮助口吃儿童树立信心，帮助他们寻找最流利、最轻松的说话方式，并让他们大胆练习；同时，还应要求班上的同学既不能模仿口吃的同学说话，也不能嘲笑、捉弄、挖苦、讽刺、打击口吃同学说话的积极性，应注意保护他们的自尊心。

12.学习障碍

在小学教室里我们常常会遇到一些功课不好、学习速度缓慢的儿童，他们读书会漏字、错行；写字少笔画、写反字；做数学作业，会把题目抄写错、把计算步骤搞丢等。通常在家长的眼里会认为自己的孩子还算聪明，就是太贪玩，不用心学习。其实他们是学习困难儿童。学习困难是一种隐藏的缺陷，在孩子年龄小的时候往往不能被发现。当他们上小学后，老师很快会发现，这些孩子在学校的表现不能达到预期的水平，在完成学校作业时，经常遇到阅读、书写或算术方面的困难，导致实际的学习成绩与预期的成绩出现了明显的差距。

学习困难主要分为三种类型：阅读障碍、书写障碍和书面表达障碍。其中阅读障碍是最常见的，病因可能是由于大脑处理视觉信息的生理异常产生的语音问题导致的。据估计，学习障碍在学龄儿童中的患病率为 10% ～15%，被确认为有学习障碍的儿童中，男孩多于女孩。患有学习障碍的学生中，约有三分之一的人最终以退学的方式结束学校生活[2]。

如果有充分的发展机会且能发挥特殊教育的优势，学习障碍儿童成年期的预后效果一般情况下还是比较好的。目前，使用认知行为技术、计算机辅助教育等手段治疗学习障碍已取得了良好的效果。

著名教育家夸美纽斯认为，“儿童是上帝最珍贵的恩赐，是任何事物不能与之比拟的宝物”。因此，必须给予他们极大的关怀。儿童心灵的健康发育为其人生的发展打下了良好的基础。作为人类灵魂工程师的教师，关注儿童心灵的成长、促进儿童人格的发育是我们义不容辞的责任。

参考文献：

[1]张承芬，孙维胜 .学生心理健康教育 [M].北京：警官教育出版社，1997.

[2]王建平，梁耀坚，汤宜朗 .变态心理学 [M].北京：高等教育出版社，2005.

[3]赵淑文：小学生心理发展与心理健康 [M].北京：首都师范大学出版社，2005.

[4][美]艾里克 · J·马施，大卫 · A·沃尔夫 .儿童异常心理学 [M].广州：暨南大学出版社，2004.

[5][美]John Briere & Catherine Scott.心理创伤的治疗指南 [M].徐凯文，等，译 .北京：中国轻工业出版社，2009.

[6]陈维樑，钟莠苟 .哀伤心理咨询：理论与实务 [M].北京：中国轻工业出版社，2006.

〔责任编辑：张　华〕

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net